

Ethique médicale

A. Aspects médico-légaux de la relation médecin-patient

Le mandat du médecin traitant est clair et sa relation ne concerne **que le patient** avec lequel il a conclu un mandat. On parle de contrat **d'obligation de moyens** et non pas de contrat de résultat. Les soins doivent être consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises par la science. Le médecin va donc pouvoir **être payé même s'il n'arrive pas à guérir son patient**.

1. Rôle du médecin

Le médecin a pour mission **de protéger la vie de l'être humain**, de promouvoir et de maintenir sa santé, de soigner les maladies, d'apaiser les souffrances et d'assister les mourants jusqu'à leur dernière heure (code de Déontologie de la FMH).

"Quoi que je voie ou entende dire dans la société pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui ne doit pas être divulgué, le regardant comme un secret inviolable". Hippocrate a ainsi été la première personne à définir par son serment **le secret médical**. Ce secret est important, notamment pour maintenir le lien de confiance avec le patient. Le secret médical **appartient au patient**.

2. Secret professionnel

Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, **médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes**, ainsi que leurs auxiliaires qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, **sur plainte**, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Seront punis de la même peine **les étudiants** qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance **à l'occasion de leurs études**. La révélation **demeure punissable** alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.

2.1 Devoirs professionnels

Les personnes exerçant une profession médicale **universitaire à titre indépendant** doivent observer les devoirs professionnels suivants :

- Exercer leur activité avec **soin et conscience professionnelle** et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation post grade et de leur formation continue
- Approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par **une formation continue**
- Garantir **les droits** du patient
- **S'abstenir de toute publicité** qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général. Cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner
- Défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement **les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers**
- **Observer le secret professionnel** conformément aux dispositions applicables
- Prêter assistance en cas d'urgence et **participer aux services d'urgence** conformément aux dispositions cantonales
- Conclure **une assurance responsabilité civile professionnelle** offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.

2.2 Autorité cantonale de surveillance

Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale à titre indépendant sur son territoire. Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour **faire respecter** les devoirs professionnels. Le **Conseil de santé** est l'autorité de surveillance compétente pour délier le secret professionnel dans certaines situations bien définies.

3. Droit des patients

Les patients ont le droit de choisir librement le professionnel de la santé dans le cas **d'un traitement ambulatoire**, le droit de choisir **l'établissement sanitaire d'intérêt public** et le droit de **choisir leur hôpital** (selon possibilités).

3.1 Droit à l'information

Le droit à l'information rassemble les connaissances sur **le diagnostic et le pronostic**, les investigations, les traitements, les mesures de prévention, l'utilité, l'urgence, la durée et les risques. Le patient doit aussi comprendre **les alternatives et les risques**, les aspects financiers du traitement et **les conséquences en cas de refus**. Le droit à l'information est obligatoire sauf en situation d'urgence ou si **le patient ne veut pas savoir**. En présence **de litige**, c'est au médecin d'apporter la preuve que l'information a été donnée.

3.2 Droit à l'accompagnement

Le patient a aussi le droit une assistance et des conseils pendant toute la durée de son séjour. Il a le droit de demander le soutien de ses proches, de maintenir le contact avec son entourage et il peut aussi bénéficier d'accompagnants extérieurs désignés par des **organisations indépendantes à but non lucratif**.

3.3 Droit d'accès au dossier médical

Le patient a le droit de consulter son dossier médical, mais il n'a pas le droit d'accéder aux notes personnelles du médecin. Les personnes exerçant à titre indépendant une profession de la santé tiennent pour chaque patient un dossier résumant leurs observations, les prestations fournies ou prescrites et l'évolution du cas. Le dossier appartient au praticien, à l'établissement sanitaire ou à l'organisation de soins. Il doit être **accessible** au remplaçant ou au successeur du praticien. La récolte de données sur un patient obéit aux principes suivants : **bonne foi, proportionnalité, finalité et exactitude**. La loi sur le dossier électronique devrait entrer en vigueur en 2017.

Le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix. Ce droit ne s'étend pas aux **notes rédigées** par le professionnel de la santé exclusivement pour son **usage personnel**, ni aux **données concernant des tiers couverts** par le secret professionnel.

Attention, si le professionnel de la santé a des raisons de craindre que la consultation du dossier puisse avoir de **graves conséquences** pour le patient, il peut demander que la consultation **n'ait lieu qu'en sa présence** ou celle d'un **autre professionnel désigné par le patient**.

3.4 Consentement libre et éclairé

Pour des choses banales, on a un consentement tacite. Le patient s'il donne son consentement libre et éclairé a le droit de refuser un traitement, que ce soit les adultes pour eux-mêmes ou les parents pour leur enfant. Il faut être très attentif à l'incapacité de discernement, aux directives anticipées et aux volontés présumées. **Aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement**, qu'il soit **majeur ou mineur**. Etre capable de discernement, c'est avoir la faculté d'évaluer une situation, de prendre des décisions pertinentes en conséquence et **d'apprécier la portée de ses actes**. Toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée

par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, **est capable de discernement dans le sens de la présente loi.**

4. Assistance au suicide

Celui qui, poussé par un mobile **égoïste**, aura incité une personne, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, **puni** d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le patient doit être capable **de discernement et pouvoir boire lui-même la potion.**

5. Meurtre sur demande de la victime

Celui qui cédant à un **mobile honorable**, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6. Expertises

Le médecin **ne peut pas garantir** le résultat du traitement, mais il est tenu de pratiquer la médecine selon les règles de l'art. Il existe une différence **entre erreur et faute**. Il est **possible de faire une erreur sans qu'il y ait faute**. Commettre une faute, c'est se tromper parce que l'on n'a **pas agi comme un bon professionnel aurait agi dans les mêmes circonstances**. Dans les situations d'expertise, on va faire appel à un expert qui est quelqu'un d'indépendant qui a **les mêmes niveaux de connaissance que le médecin accusé**.

6.1 Obligations du médecin

Le médecin a l'obligation de respecter les règles de l'art (chaque situation est examinée individuellement par les tribunaux) et d'informer le patient. Il faut savoir que **les erreurs de diagnostic** sont très courantes.

6.2 Questions posées aux experts

Le problème du patient a-t-il été analysé correctement (anamnèse) ? Les examens choisis étaient-ils appropriés ? Le médecin a-t-il procédé correctement à l'exécution des examens et les résultats ont-ils été analysés correctement (diagnostic) ? Le médecin a-t-il choisi **des traitements appropriés**, l'indication était-elle justifiée et nécessaire ? Existait-il **des alternatives sérieuses** ? Le médecin a-t-il procédé **correctement à l'exécution de ces traitements** ? Les contrôles ultérieurs prescrits étaient-ils adéquats ? **Les instructions données** au patient quant au comportement à adopter étaient-elles correctes ?

Si la **faute est démontrée**, le médecin peut être jugé pour **homicide ou lésion corporelle par négligence**.

Les expertises **extra-judiciaires** de la FMH sont indiquées dans les situations suivantes :

- Le patient soupçonne une faute de diagnostic ou de traitement
- La faute présumée a conduit à un **dommage considérable de sa santé**
- **Aucun accord n'a pu être trouvé** avec l'assureur responsabilité civile (RC) de l'hôpital ou du médecin concerné

Dans la plupart des expertises, **le médecin est blanchi** car il avait bien fait son travail.

B. Aspects médico-légaux du secret médical

Les professionnels qui auront révélé un secret confié **seront punis** d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Les étudiants seront également punis et la révélation demeure punissable même si le détenteur du secret n'exerce plus sa fonction ou qu'il a terminé ses études. Le SP **s'applique également entre professionnels de la santé**, mais lorsque les intérêts d'un patient l'exigent, les professionnels de la santé peuvent, avec le consentement du patient, **se transmettre des informations le concernant**.

La violation du SP est réprimée par la loi. Le SP s'étend aux constatations d'ordre médical et à tous les faits parvenant à la connaissance du médecin lors de son exercice. La violation du SP n'est punissable que sur plainte.

La révélation **ne sera pas punissable** si elle a été faite avec le consentement du patient ou si, sur proposition du détenteur du secret, **l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit**. La personne astreinte au secret professionnel dénonce les cas de maltraitance et de soins dangereux à l'autorité compétente.

1. Levée du secret

Le SP peut être levé **par le patient lui-même, par les dispositions de la législation fédérale ou cantonale ou encore par l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance**. Le consentement du patient c'est la règle d'or. Le SP n'est pas opposable au malade. Le médecin délié du secret par son patient devrait, sauf situation d'exception, respecter la demande du patient. Seul un consentement émanant d'un patient **capable de discernement** est juridiquement valable.

1.1 Consentement du patient

On est obligé de délivrer au patient un certificat s'il nous le demande. Il faut toujours soumettre **au contrôle du patient** les documents à l'attention d'un tiers et on doit informer le patient de manière exacte et compréhensible.

On sépare les dérogations **obligatoires** (quand le médecin doit parler) des dérogations **facultatives** (quand le médecin *peut* parler).

a. Dérogations obligatoires

- Acte de naissance, certificat de décès
- Maladies transmissibles
- Interruption de grossesse
- Maltraitance d'enfant
- Morsures de chien
- Lésions en relation avec le service militaire
- Effets désirables graves ou inconnus de produits thérapeutiques ou de dispositifs médicaux.

Loi sur les épidémies

Le Conseil Fédéral ordonne **aux médecins et aux hôpitaux de déclarer à l'autorité fédérale compétente les cas de maladies transmissibles chez des personnes malades, infectées ou exposées avec des indications permettant d'identifier ces personnes**. L'autorité cantonale transmet ces informations à l'OFSP. Les laboratoires sont aussi tenus de déclarer les résultats d'analyses infectiologiques avec des indications permettant d'identifier les personnes malades ou infectées. Les maladies transmissibles qui doivent être déclarées entrent dans les catégories suivantes :

- Mesures de prévention connues contre les conséquences
- Maladies responsables de poussées importantes
- Evolution grave mais susceptible d'être influencée
- Surveillance régie par une convention internationale
- Maladie d'un genre nouveau ou inattendue

IVG

A des **fins statistiques** , toute IVG doit être annoncée à l'autorité de santé publique compétente. **L'anonymat** de la femme concernée **est garanti** et le secret médical doit être respecté.

Loi sur la protection des mineurs

Toute personne **peut signaler** la situation d'un mineur en danger, mais toute personne qui, **dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs**, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation d'un mineur en danger dans son développement pouvant justifier l'intervention du département, **a le devoir de la lui signaler**.

Maltraitance (loi Vaudoise)

L'article 80a alinéa 1 de la Loi vaudoise sur la santé publique **oblige le professionnel de la santé à dénoncer une situation gravement préjudiciable pour le patient** et à alerter l'autorité compétente **sans craindre** d'enfreindre le secret professionnel, et ce notamment lorsque le patient se trouve dans une situation de **dépendance où il peut difficilement se défendre** (psychiatrie, gériatrie, enfance entre autres).

Etat de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Morsures de chien

Le corps médical a l'**obligation** d'annoncer au service de la consommation et **des affaires vétérinaires** les coordonnées de la victime (avec son consentement) et les coordonnées du détenteur du chien.

Produits thérapeutiques

On note une obligation d'annoncer **un effet indésirable grave ou jusque-là inconnu, un incident ou un défaut d'un produit thérapeutique ou d'un dispositif médical** pour quiconque, à titre professionnel, administre des produits thérapeutiques. Cette annonce doit se faire au **centre régional de pharmacovigilance**. L'annonce se fait de manière anonymisée.

Lésions en relation avec le service militaire

Le médecin, le dentiste ou le chiropraticien consulté est tenu d'annoncer **immédiatement le cas à l'assurance militaire lorsqu'il peut y avoir une relation entre l'affection et le service accompli**. Il doit en particulier annoncer le cas lorsque le patient ou ses proches le demandent.

b. Dérogations facultatives

Le SP peut être levé facultativement dans les situations suivantes : **circulation routière, stupéfiants et substance psychotropes et mineurs**.

Circulation routière

Tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire **les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté** un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.

Stupéfiants et substances psychotropes

Les médecins, les pharmaciens et les services administratifs sont **autorisés** à signaler à l'autorité protectrice compétente les cas d'abus de stupéfiants qu'ils constatent dans l'exercice de leur fonction lorsqu'ils estiment que des mesures de protection sont indiquées **dans l'intérêt du patient, de ses proches ou de la communauté**.

Les professionnels sont également encouragés dans leur pratique professionnelle à lutter contre les abus de médicaments ou de substances nocives. Dans les cas d'abus graves, ils peuvent avertir le médecin cantonal.

1.2 Autorité supérieure ou de surveillance

Quand ni **le patient ni la loi** ne lève le SP, le médecin **peut demander à en être délié** par l'autorité supérieur/de surveillance désignée dans chaque canton. En général, l'autorisation est donnée lorsque l'intérêt de la **divulcation l'emporte** sur celui du maintien du secret. Dans le Canton de Vaud, l'autorité supérieure est représentée par le Conseil de santé.

Conseil de santé

Chaque canton désigne **une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale à titre indépendant sur son territoire**. Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Le Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour **déliver du secret professionnel** les personnes exerçant une profession visée par l'article 321 du Code pénal suisse et régie par la présente loi. Le CS est composé de 16 membres variés.

Lorsque le secret est délié, le médecin doit veiller à **la pertinence et à la proportionnalité** des renseignements fournis. Si le patient est **incapable de discernement**, il convient d'abord de rechercher s'il existe **un représentant légal**. Finalement, **le secret perdure après la mort du patient**.

2. Secret médical et justice

On sépare **le médecin témoin, le médecin expert et le médecin accusé**.

Médecin témoin

Le médecin témoin a l'obligation de témoigner en justice. Il doit suivre les recommandations suivantes. Il ne doit pas mentir, il doit garder à l'esprit l'intérêt de son patient, respecter le principe de proportionnalité et être attentif aux intérêts des tiers. Le patient libère le médecin témoin du secret médical **par rapport à l'affaire qui est jugée**.

Médecin expert

Le médecin expert **n'est pas choisi par la même personne examinée** mais par l'autorité requérante. Le médecin expert rend son rapport à l'autorité requérante. D'un point de vue médico-éthique, la personne examinée doit être informée du statut particulier de l'expertise. Le médecin expert doit fournir au mandant (autorité requérante) **un rapport objectif** même en présence d'éventuelles conséquences défavorables pour l'expertisé.

Médecin accusé

Concernant le médecin accusé, on note **une levée officielle du secret quand il défend ses intérêts**.

3. Assurances privées et assurances sociales

3.1 Assurances privées

L'assureur n'a **pas le droit d'exiger** toutes les informations relatives à la santé de la personne qu'il assure. Le demandeur d'assurance a un devoir de renseigner l'assureur **limité aux seuls faits pertinents**. Le médecin de l'assuré ne peut renseigner l'assureur **que si le patient l'y a autorisé**, en respectant les règles générales de la protection des données.

3.2 Assurance maladie

L'assureur peut exiger un **diagnostic précis** ou des **renseignements supplémentaires d'ordre médical**. Les indications d'ordre médical peuvent être transmises uniquement au médecin conseil de l'assureur, expressément si le patient le demande.

C. Directives anticipées

Les directives anticipées correspondent à une **expression écrite par avance** de la volonté d'une personne sur **le type de soins qu'elle souhaite recevoir ou non** lors de situations données et au cas où elle ne serait pas en mesure de **s'exprimer par elle-même**. Cette démarche est volontaire et non-obligatoire.

1. Objectifs des DA

Les directives anticipées (DA) nous permettent de **prolonger dans le temps** notre possibilité d'exercer notre **droit à l'autodétermination** en ce qui concerne notre santé jusqu'à la mort et **notre corps après la mort** et de participer aux décisions médicales nous concernant, **au-delà de notre capacité d'expression**.

En revanche, les directives anticipées (DA) **ne nous permettent pas** de demander un traitement **non-reconnu ou non prodigué** dans un établissement donné, de choisir un hôpital particulier, d'exiger de rester à domicile en toutes circonstances, de **demander** l'assistance au suicide ou l'euthanasie active directe et de disposer de ses biens (testament).

2. Historique

Les fondements des DA se basent sur la **reconnaissance du droit du patient à l'autodétermination**. Elles s'inscrivent dans la **Loi fédérale** suite à la révision du **Code civil en 2013** (après des lois cantonales précédentes).

Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Elle peut également désigner une personne physique (représentant(s) thérapeutique(s)) qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.

Ainsi, les DA ne servent à rien tant que la personne a sa capacité de discernement. Finalement, il faut savoir que la désignation du représentant thérapeutique n'est pas anodine (risque de conflits familiaux et de conflits d'intérêt).

3. Statistiques

Le taux de remplissage des DA en Suisse **est de seulement 5%**. On observe donc **un faible impact des mesures éducatives et promotionnelles**. Les causes de ce faible taux de remplissage peuvent être expliquées par les éléments suivants :

- **Résistance à penser à la mort**
- Méconnaissance des DA
- **Dimensions culturelles**
- Langage technique
- **Perçues comme inutiles** (surtout les personnes très âgées)

4. Controverses

Les DA soulèvent toute une série de controverses que nous allons illustrer une par une :

- **Utilité des directives**

- Compréhension de la situation médicale
- Stabilité des choix
- Conditions de rédaction
- Manière dont elles sont interprétées
- Manière dont elles sont utilisées

a. Utilisé des DA

Une étude a montré que sur les quelques 600 directives anticipées effectuées, **30% donnaient des informations générales inutiles**, 13% avaient des instructions spécifiques sans lien avec la situation médicale et seulement 3% donnaient **des instructions spécifiques en lien avec la situation médicale**. Finalement, parmi ces 3%, **seul 1%** des instructions spécifiques ont été appliquées.

b. Compréhension de la situation médicale

Les représentations des patients de la réalité médicale et la mort sont **souvent très confuses et influencées par les médias**. Dans une étude, la majorité des patients estimaient qu'une réanimation cardiorespiratoire était réussie sans séquelle **dans 50-90% des cas**, alors qu'en réalité, ce taux est **plus proche des 13-30%**

c. Stabilité des choix

Environ une personne âgée sur deux modifie ses choix de manière significative dans un délai de deux ans. La stabilité des choix dépend de l'état de santé, des circonstances médicales au moment du choix et de l'environnement psycho-social. Théoriquement, il faut refaire les DA tous les deux ans, mais il serait mieux de les mettre à jour **tous les ans ou à chaque période de crise**.

d. Condition de rédaction

Le temps moyen de rédaction d'une DA est d'environ 3 heures (scindées en de multiples rendez-vous). Une étude américaine a montré qu'en moyenne, l'entretien durait 5.6 minutes, avec les $\frac{3}{4}$ du temps de parole prise par le médecin. Seulement **25% des patients** ont été informés de la possibilité poser des questions, seule la moitié des patients a été informée d'une rencontre possible ultérieure et 16% ont reçu l'information qu'ils pouvaient modifier leur décision. Les DA sont chronophages, mais il faut prendre ce temps. Il est essentiel de dire aux patients qu'ils peuvent changer en tout temps leurs DA et même les annuler.

e. Compréhension des DA

Dans le cas d'une présentation de DA appliquée à une situation clinique (pas d'acharnement thérapeutique dans le cas d'une démence avancée avec pneumonie) à des médecins et des infirmières, les conclusions sont souvent divergentes en raison des **variations l'interprétation liées à l'ambiguïté des termes utilisés**.

f. Utilisation des DA

Pour tester l'utilisation des DA, on a corrélié des scénarios de DA et l'attitude adoptée par des patients, des infirmières et des médecins. Une certaine ambivalence ressort de cette étude. Les participants doivent dire si la décision (souvent réanimation) est juste au vue des DA, si elle est fausse et s'ils auraient voulu être réanimés ou pas alors sachant que les DA contenaient un ordre de non-réanimation.

On voit que les médecins et les infirmières ont **plus tendance à suivre les DA et à ne pas vouloir être réanimés**, tandis que les patients ont plus jugé la décision fausse et auraient souhaités être réanimés malgré les DA de non-réanimation. De plus, les médecins ont plus peur que les proches insistent sur la cessation du traitement sur la base des DA, malgré un bon pronostic.

5. Bénéfice des DA

Les bénéfices des DA sont les suivants :

- Augmentation de la satisfaction
- Diminution de l'anxiété et de la dépression
- Meilleure compréhension de son état de santé
- Sentiment d'un meilleur contrôle sur l'orientation des traitements
- Sentiment d'une **meilleure compréhension du médecin traitant et des proches à l'égard de ses souhaits**

6. Comment faire mieux ?

On parle actuellement plutôt de **planification du projet thérapeutique**. Cette planification est centrée sur **l'entière de l'individu** et non pas seulement sur des directives strictement médicales. On va d'abord définir **ce que souhaite le patient** avant de définir ce qu'il ne veut pas.

6.1 Planification du projet thérapeutique

La planification du projet thérapeutique vise à **définir les objectifs prioritaires des soins pour et par le patient**. On va commencer par évaluer ce que le patient **connaît de sa maladie** (cours de la maladie, complications possibles et espérance de vie). On va aussi voir quelles sont les **valeurs de vie** importantes pour le patient.

a. Valeurs de vie

- Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ?
- Qu'est-ce qui, à mes yeux, rend la vie digne d'être vécue ?
- **Quelles personnes comptent pour moi, pourquoi ?**
- Quelle importance j'attache à mon apparence ?
- Que représente **la souffrance pour moi ?**
- Que représente **la mort pour moi ?**

6.3 Besoins et craintes

On va évaluer **les craintes de nos patients**, notamment la douleur, la difficulté à respirer, l'agonie prolongée, l'abandon ou encore la peur d'être une charge notamment financière pour les autres. Finalement, on va investiguer leurs connaissances sur **les moyens mis à disposition par les soins palliatifs**.

6.4 Go Wish

On va faire **trois tas avec des cartes** représentant **différentes valeurs** : **valeurs prioritaires, valeurs moyennement prioritaire et valeurs pas du tout prioritaire**. On va ensuite analyser chaque carte et essayer de comprendre pourquoi le patient a placé cette valeur dans l'un des trois tas. On fait une photographie de ces valeurs et on ajoute **les commentaires du patient**. Ensuite, on discute avec le représentant thérapeutique s'il n'est pas présent dès le départ. Ces données sont ensuite transmises dans le formulaire officiel des DA.

1 Ne pas avoir de douleur	2 Ne pas avoir d'angoisse	3 Maintenir ma dignité	4 Ne pas être essouffé	5 Ne pas être branché à des machines	6 Avoir un contact humain	7 Avoir ma famille avec moi	8 Avoir une personne qui m'écouterait	9 S'occuper des affaires non réglées avec ma famille / amis	10 Être capable de parler de ce qui me fait peur
11 Être mentalement conscient	12 Avoir un médecin qui me connaît de manière globale	13 Avoir confiance en mon docteur	14 Avoir un défenseur qui connaît mes valeurs et priorités	15 Faire mes adieux aux personnes importantes de ma vie	16 Ne pas être un fardeau pour ma famille	17 Avoir une infirmière avec laquelle je me sens à l'aise	18 Garder mon sens de l'humour	19 Avoir préparé mes obsèques	20 Avoir le sentiment que ma vie est complète
21 Ne pas mourir seul	22 Être traité comme je veux	23 Se souvenir des réalisations personnelles	24 Être géré propre	25 Être capable d'aider les autres	26 Prévoir les querelles en m'assurant que ma famille sait ce que je veux	27 Avoir ma famille préparée à ma mort	28 Avoir des amis proches à mes côtés	29 Être capable de parler de ce que la mort signifie	30 Mourir à la maison
31 Rencontrer un prêtre ou un pasteur	32 Avoir mes affaires financières en ordre	33 Savoir comment mon corps va changer	34 Être en paix avec Dieu	35 Prier	JOKER				

90% des patients sont d'accord de faire la démarche avec les cartes, les 10% restant refusent et font seulement les DA (souvent déjà faites avant même la consultation). Pour les patients sans aucun intérêt pour les DA, il faut essayer de leur dire d'au moins désigner un ou plusieurs représentants thérapeutiques. Si l'intérêt est limité, on essaie toujours de faire désigner un représentant thérapeutique au patient et on lui propose de la

documentation. Finalement, si l'intérêt du patient est grand, on lui propose de construire la planification du projet thérapeutique avant de faire ses DA.

7. Contenu des DA

Les DA contiennent les éléments suivants :

- **Echelle personnelle des valeurs.**
- **Objectifs thérapeutiques prioritaires.**
- Situations futures d'application décrites aussi **précisément que possible.**
- Formulaires trop normatifs à éviter.
- Ne pas exprimer des souhaits strictement médicotechniques.
- **Eviter l'exclusion générale de certaines mesures**, indépendamment de la situation d'application

8. Conseils pratico-pratiques

C'est notre rôle **d'ouvrir les portes et de stimuler l'intérêt de nos patients** à la possibilité des DA. Il faut associer les proches autant que possible pour autant que le patient soit d'accord et discuter également avec le médecin de famille. Il s'agit d'un processus continu et il faut donc **réévaluer régulièrement les DA en fonction de l'évolution de l'état de santé du patient** (amélioration, péjoration, situation de crise). Finalement, il faut **faciliter un accès en tout temps aux DA**.

D. Approche psychiatrique des DA

Les DA font partie du Code civil suisse, dans le chapitre du droit de la famille (3^e partie, protection de l'adulte).

Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

Les DA permettent à une personne capable de discernement de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement, de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, également pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement.

1. Forme des DA

Les DA doivent être écrites, datées et signées par leur auteur. Il est conseillé de faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d'assuré.

Le médecin doit les respecter **sauf** si elles **violent des dispositions légales**, si des **doutes sérieux** laissent supposer qu'elles ne sont pas l'expression de la libre volonté ou qu'elles ne correspondent pas à la volonté présumée de la personne dans la situation donnée.

2. Amélioration de la prise en charge : application des DA en en psychiatrie

Chaque directive anticipée apporte **une plus-value et/ou une amélioration** dans la prise en charge des patients (notamment dans des aspects de prévention). Cette amélioration n'offre pas toujours une lisibilité immédiate pour les patients, les proches ou les soignants. La notion de chantier qui s'ouvre est importante car elle intègre **le respect du rythme et des moyens qui sont propre à chacun**.

3. DA comme outil de communication

Les DA permettent de recherche des éléments de prévention de la rechute avant l'hospitalisation. Elles permettent aussi un retour sur les modalités de l'hospitalisation (vécu du patient et vécu des soignants) et une mise en relation des éléments de la prévention de la rechute avant l'hospitalisation et du déroulement de l'hospitalisation. Finalement, elles sont aussi utiles pour l'évaluation du niveau de conscience morbide.

Si on ne peut pas toujours empêcher une hospitalisation, la rédaction de DA peut améliorer les conditions futures d'hospitalisation. Les DA permettent donc d'améliorer les éléments de la prévention de la rechute en recherchant **des signes annonciateurs de rechute** grâce à la mise en place d'un système d'alerte.

4. Enjeux pour le patient

- Redevenir **l'acteur et le décideur de ses soins**
- **Anticiper et prévenir la crise**
- Développer **sa conscience morbide**
- **Collaborer et discuter** plutôt que subir et s'opposer, partager ses compétences

5. Enjeux pour le soignant

- Offrir une **continuité des soins**
- Renforcer la collaboration entre les soignants et les patients
- Valoriser la fonction de soignant hospitalier par la légitimité qu'elle offre dans l'analyse de la crise
- Développer **la conscience morbide du patient au bon moment** (efficience du soin)

6. Questions en suspens

Les DA posent encore quelques problèmes d'application pratique, notamment leur accessibilité, leur utilisation dans une situation d'urgence et leur actualisation.